

上海交通大学医学院附属新华医院健康管理中心

体检报告

身份证号: 61212919760829****

个人



部门:

姓名: 王艺锋

性别: 男 年龄: 49

体检日期: 2025-09-05

体检编号: 95279069

2025-09-18 主检: 姚迪

2025-09-18 总检: 



尊敬的王艺锋贵宾:

您好!

我们很荣幸为您完成了本次健康体检。现将您的健康体检报告呈上。请您关注本次健康体检的异常部分,并仔细阅读专家的健康指导建议。我们建议您对异常的结果进行随访复查和其他相关检查,每年进行1-2次全面的健康体检。

异常结果:

1、内镜室:

反流性食管炎(LA-A),隆起糜烂性胃窦炎,建议定期复查。

所检结、直肠粘膜未见异常,内痔。建议内镜专科门诊或消化科门诊随访,定期复查。

2、病理科-内镜:

胃镜病理:“胃窦”轻度慢性非萎缩性胃炎,HP(-)。

3、医学影像科-MR:

双侧上颌窦黏膜下囊肿,筛窦炎。

4、医学影像科-X线摄片:

颈椎退行性改变。

5、一般检查:

收缩压: 142 mmHg ↑; 舒张压: 95 mmHg ↑;

6、检验科-生化:

乳酸脱氢酶(LDH5): 17.8 % ↑; 碱性磷酸酶(ALP): 135 U/L ↑; 白蛋白(ALBUMIN): 67.6 % ↑; 锌: 28.39 umol/L ↑; 低密度脂蛋白(LDL-C): 3.06 mmol/L *; 载脂蛋白E: 4.9 mg/dL ↑。

7、检验科-免疫:

总25-羟维生素D: 38.68 nmol/L ↓; 总P1NP: 141.30 ng/mL ↑; IgE-户尘螨: 19.30 IU/ml; IgE-粉尘螨: 51.10 IU/ml; IgE-热带无爪螨: 7.90 IU/ml; 糖类抗原 (CA724): 7.86 U/mL ↑; TPO-Ab: 123.90 U/mL ↑; CMV-IgG: 110.00 U/mL ↑; 风疹病毒IgG: 42.70 IU/mL ↑; EB病毒抗体测定EBNA-G: >600.00 U/mL ↑; EB病毒抗体测定EBV-CA: 90.20 U/mL ↑;

8、检验科-血液:

全血粘度低切: 10.91 CP ↑; 全血粘度中切: 8.17 CP ↑; 全血粘度高切: 6.37 CP ↑; 血浆粘度: 1.78 CP ↑。

9、骨密度:

骨密度测定: 骨量减少;

10、超声诊断科-腹部:

1) 胆囊结石

2) 左肾囊肿

11、超声诊断科-泌尿系统:

前列腺钙化灶

12、口腔科:

牙龈炎, 建议择期牙周治疗

13、人体成分测定:

人体成分分析: 肥胖型;

健康干预手段

●反流性食管炎 (LA-A), 隆起糜烂性胃炎; 胃镜病理: “胃窦”轻度慢性非萎缩性胃炎, HP (-)

建议到内镜专科门诊或消化科门诊随访诊治。

●痔疮

建议保持大便通畅; 症状严重者, 建议到内镜专科门诊或肛肠外科诊治。

●反流性食管炎

反流性食管炎是指胃、十二指肠内容物反流入食管内引起的食管炎症性病变, 可表现为上腹部不适、胸骨后烧灼感、胸痛等, 建议结合症状到消化内科诊治。

●胃镜病理: 慢性非萎缩性胃炎

慢性非萎缩性胃炎是指胃粘膜不伴有萎缩性改变、以慢性炎症细胞浸润为主的慢性胃炎。可无症状, 可表现为上腹不适、饱胀、嗝气恶心等非特异性症状。如无症状、幽门螺旋杆菌阴性, 可不作特殊治疗; 如有症状或幽门螺旋杆菌阳性, 建议到消化科治疗。

●上颌窦粘膜下囊肿

上颌窦粘膜下囊肿是鼻窦囊肿中常见的类型, 可能是黏液腺阻塞、分泌物潴留、黏膜炎症等引起。囊肿较小且没有明显症状时, 建议随访; 囊肿较大引起面部压痛、胀痛、牙痛、鼻塞鼻涕等, 建议到耳鼻喉科诊治。

●头颅MRI附见筛窦炎

建议结合病史、症状等到耳鼻喉科或头颈外科门诊随访复查或进一步检查。

●颈椎退行性改变

健康干预手段

建议您到骨科随诊诊治。

● 血压高

初次血压高，建议安静状态下非同一日复查三次以上；如仍高，建议到心内科就诊诊治；高血压患者建议低脂、低盐清淡饮食（食盐每日6g以下）、低热量饮食，多吃新鲜蔬菜和水果，戒烟限酒，适量运动，减轻精神压力，医师指导下合理选择降压药物，在心内科门诊定期随访检查血压、心电图、血脂、血黏度。

● 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C） ≥ 1.4 且 < 3.4 （单位：mmol/L）

LDL-C是动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）的致病危险因素，是降脂治疗的首要靶点，其目标值（参考值）因人而异，需结合个体化危险因素进行分层评估。健康人群或ASCVD低危人群LDL-C应 < 3.4 （理想水平 < 2.6 ），中、高危人群应 < 2.6 ，极高危人群应 < 1.8 ，超高危人群应 < 1.4 。如既往有高血压、冠心病、心梗等心血管系统疾病、和/或糖尿病、脑梗、慢性肾病、脂代谢异常等疾病，男性 ≥ 45 岁/女性 ≥ 55 岁，建议到心内科门诊进行心血管危险分层评估以确定血脂水平是否达标及是否需要降脂治疗。已接受降脂治疗者，请根据既往危险分层确定血脂是否达标，并到心内科门诊定期复查。

● 肝功能：碱性磷酸酶升高

碱性磷酸酶主要存在于肝脏、骨骼、肾脏等，所以常作为肝胆疾病和骨骼疾病的临床辅助诊断指标。建议复查，如仍升高，建议到消化内科或骨科进一步检查。

● 血清锌增高

血清锌增高主要见于甲亢、高血压及癫痫等患者。建议到内科门诊随访。

● 载脂蛋白E异常

载脂蛋白E异常通常与肝脏疾病、脂代谢疾病相关，建议结合其他指标到内科复查。

● 肿瘤标志物：CA724增高

CA724对胃癌的检测特异性较高，结肠癌、胰腺癌、肺癌也可增高，部分消化道良性疾病也可升高。建议进一步检查，并定期复查。

● 感染与免疫指标：巨细胞病毒（CMV）抗体阳性

说明曾感染过CMV，并且具有一定免疫力。阳性结果的意义还需结合临床综合判断。建议到感染科门诊就诊。

● 肿瘤相关感染指标：EB病毒抗体阳性

EB病毒与鼻咽癌、淋巴瘤的发生有关，也可引起传染性单核细胞增多症等其他疾病。大部分人都有EB病毒感染史，也就是说，鼻咽癌及部分类型淋巴瘤与EB病毒感染相关，但感染EB病毒不是一定会引发相关肿瘤。EB病毒抗体的增高在健康人群体检中主要起风险提示及辅助筛查作用，还要结合耳鼻喉科常规检查、影像学检查及临床表现，如鼻塞、流涕、涕中带血、头痛、长期发热、无痛的浅表淋巴结肿大等。如无特殊，建议到耳鼻喉科门诊就诊后常规年度体检或遵医嘱门诊定期复查。

● 感染与免疫指标：风疹病毒抗体阳性

说明曾感染过风疹病毒，并且具有一定免疫力。阳性结果的意义还需结合临床综合判断。建议到感染科门诊就诊。

健康干预手段

●过敏源筛查阳性

建议结合临床到皮肤科、内科等相关科室随诊诊治。

●甲状腺功能：抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPO-Ab）阳性

提示可能存在自身免疫性甲状腺疾病，建议到内分泌科门诊就诊、随访。

●总25-羟维生素D降低

是反映皮肤合成和食物摄取维生素D水平的最好指标。其降低见于营养性维生素D缺乏或由消化系统疾病、糖尿病、自身免疫病等引起的继发性维生素D水平降低。维生素D促进钙的吸收与骨质的钙化和新骨生成。血清总25-羟维生素D降低与骨密度减低有相关性。建议结合骨密度测定到骨科门诊进一步诊治。平时注意均衡营养，增加白天户外活动以促进维生素D的吸收与合成。

●骨代谢指标：总P1NP异常

P1NP在血清中的含量反映成骨细胞合成骨胶原的能力，是一项骨形成标志物。建议结合骨密度测定及既往病史到骨科门诊就诊、随访。

●心脑血管疾病风险：血粘度升高

引起血粘度异常的原因很多。若轻度升高，建议定期复查；若明显升高，建议到神经内科或心内科或血液科就诊、咨询。

●骨量减少

骨量减少进一步发展可引起骨质疏松，建议骨科门诊随访。

●胆囊结石

建议清淡饮食、肝胆外科随访，必要时手术治疗。

●肾囊肿

初次检出者请每3-6个月复查；囊肿较小者建议随访；较大出现压迫或肾功异常者，建议泌尿外科进一步治疗。

●前列腺钙化

请您定期复查，若您有尿频、尿急等症状时，请到泌尿外科咨询和治疗。

●牙龈炎

此病主要是由于口腔卫生不良，导致牙菌斑、牙结石及软垢在龈缘附近牙面沉积，诱发牙龈炎。建议您到口腔科诊治。平时保持良好的口腔卫生，掌握正确的刷牙方法，定期到口腔科检查。

●牙石

是附着在牙齿上的异物硬块。由于牙石本身容易吸附更多的细菌毒素，故易诱发牙龈炎、牙周炎。平时应认真刷牙，少进食松软粘性食物，清除牙石，定期到口腔科检查。

●人体成分分析：肥胖型

建议均衡饮食，适度运动，控制体重，降低体脂率。

一般检查		操作者:蔡伟文		日期: 2025-09-05	
项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位	
身高	165			厘米	
体重	62			千克	
收缩压	142	↑	90-139	mmHg	
舒张压	95	↑	60-89	mmHg	
心率	70		60-100	次/分	
小结:					
收缩压: 142 mmHg ↑; 舒张压: 95 mmHg ↑; 体重指数为22.77,					

内科		小结医生:唐明		日期: 2025-09-05	
项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位	
肺及呼吸道	正常				
心脏及血管	正常				
神经及精神	正常				
脾	肋下未触及				
其他	/				
外伤手术史	精索静脉曲张手术史				
既往史	无				
三高及心脑血管疾病史	无				
泌尿生殖系统疾病史	肾结石史				
其他慢性病史	/				
小结:					
外伤手术史: 精索静脉曲张手术史; 泌尿生殖系统疾病史: 肾结石史。					

外科		小结医生:虞永江/龚子旋		日期: 2025-09-05	
项目名称	检查结果				
皮肤	正常				
甲状腺	正常				
淋巴	正常				
四肢	正常				
关节	正常				
乳房	未查				
肛门	拒检				
其他	/				
小结:					
未见明显异常					

耳鼻喉科		小结医生:张青	日期: 2025-09-05
项目名称	检查结果		
鼻疾	无		
咽喉	(-)		
耳疾	无		
听力左	/		
听力右	/		
其他	/		
小结:	未见明显异常		

眼科1		小结医生:冯彦妍	日期: 2025-09-05
项目名称	检查结果		
其他	/		
眼底(右)	正常		
眼底(左)	正常		
小结:	未见明显异常		

眼科2		小结医生:许宇	日期: 2025-09-05
项目名称	检查结果		
视力右	/		
视力左	/		
矫正视力右	5.0(1.0)		
矫正视力左	5.0(1.0)		
辨色力	正常		
眼压右 (10-21mmHg)	19		mmHg
眼压左 (10-21mmHg)	20		mmHg
小结:	未见明显异常		

眼科特检-OCT		小结医生:冯彦妍	日期: 2025-09-05
项目名称	检查结果		
光学相干断层扫描 (右眼)	黄斑区大致正常		
光学相干断层扫描 (左眼)	黄斑区大致正常		
视网膜厚度检查 (右眼)	视网膜神经纤维层 (RNFL) 平均厚度未见明显异常		
视网膜厚度检查 (左眼)	视网膜神经纤维层 (RNFL) 平均厚度未见明显异常		
小结:			

项目名称	检查结果
光学相干断层扫描（右眼）：黄斑区大致正常；光学相干断层扫描（左眼）：黄斑区大致正常；	

项目名称	检查结果
牙体检查	未见异常
牙列检查	未见异常
智齿	未见异常
牙周检查	牙石2度，牙龈炎
唇舌颊腭部	未见异常
口腔黏膜及软组织检查	未见异常
腮腺	未见异常
颞下颌关节检查、咬合检查	颞下颌关节功能正常

小结:

牙龈炎, 建议择期牙周治疗

项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位
颜色	黄色		other	
透明度	清澈		清澈	
尿比重(SG)	1.017		1.01-1.03	
尿酸碱度	7.00		5.4-8.4	
白细胞(LEU)	阴性		<50	/uL
亚硝酸盐(NIT)	阴性		NEG	
尿蛋白(PRO)	阴性		<30	mg/dL
尿糖(Glu)	阴性		<50	mg/dL
酮体(KET)	阴性		<5	mg/dL
尿胆原(UBG)	阴性		<1	mg/dL
尿胆红素(BIL)	阴性		<1	mg/dL
尿细胞血红蛋白	阴性		<25	/uL
镜检白细胞	/		0-5	/HP
镜检红细胞	/		0-3	/HP
镜检上皮细胞	/		未找见	/HP
尿微量白蛋白	<11.70		0-30	mg/L
尿转铁蛋白	<2.41		0-2.4	mg/L
尿IgG	<4.10		0-9.6	mg/L

检验科-尿液检查		检验者:李莉	审核者:卞炳贤	日期: 2025-09-05	
项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位	
尿α1-微球蛋白	7.56		0-12	mg/L	
尿核基质蛋白	阴性(-)		阴性(-)		

小结:

未见明显异常

检验科-血液		检验者:何鑫	审核者:贾侨申	日期: 2025-09-05	
项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位	
白细胞(WBC)	6.1		3.5-9.5	10 ⁹ /L	
中性粒细胞比值(GR%)	66.60		40-75	%	
中性粒细胞绝对值(GR#)	4.07		1.8-6.3	10 ⁹ /L	
淋巴细胞比值(LY%)	23.0		20-50	%	
淋巴细胞绝对值(LY#)	1.41		1.1-3.2	10 ⁹ /L	
单核细胞比值(MO%)	5.7		3-10	%	
单核细胞绝对值(MO#)	0.35		0.1-0.6	10 ⁹ /L	
嗜酸粒细胞比值(E0%)	3.7		0.4-8	%	
嗜酸粒细胞绝对值(E0#)	0.23		0.02-0.52	10 ⁹ /L	
嗜碱粒细胞比值(BA%)	1.0		0-1	%	
嗜碱粒细胞绝对值(BA#)	0.06		0-0.06	10 ⁹ /L	
红细胞(RBC)	5.25		4.3-5.8	10 ¹² /L	
血红蛋白(HGB)	158		130-175	g/L	
红细胞压积(HCT)	47.2		40-50	%	
红细胞平均体积(MCV)	89.8		82-100	f1	
红细胞平均血红蛋白含量(MCH)	30.0		27-34	pg	
红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)	334		316-354	g/L	
红细胞分布宽度(CV)	13.6		11.6-15	%	
血小板计数(PLT)	158		125-350	10 ⁹ /L	
血小板平均体积(MPV)	12.50		7.8-12.5	f1	
血沉	2.77		0-15	MM/H	
全血粘度低切	10.91	↑	7.06-10.56	CP	
全血粘度中切	8.17	↑	6.07-7.35	CP	
全血粘度高切	6.37	↑	4.4-6.24	CP	
血浆粘度	1.78	↑	1.15-1.75	CP	
红细胞聚集指数	7.61		6.1-9.18		

检验科-血液	检验者:何鑫	审核者:贾侨申	日期: 2025-09-05	
项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位
全血高切还原粘度	5.49		4.12-8.22	
全血低切还原粘度	14.07		9.26-19.18	
毛细管血浆粘度	1.78	↑	1.15-1.75	CP
血沉方程K值	12.31		0-93	
红细胞刚性指数	7.61		6.04-12.4	
红细胞变形指数	0.85		0.63-1.55	
红细胞电泳指数	20.70	↑	14.3-20.28	
血浆凝血酶原时间（PT）	11.20		9-13	s
凝血酶原时间 (INR)	0.97		0.84-1.19	
活化部分凝血活酶时间（APTT）	30.7		26-39	s
血浆纤维蛋白原	2.62		2-4	g/L
凝血酶时间（TT）	14.20		12-17	s
血型ABO	0型			
血型（RH）	阳性			
血型抗筛检测	阴性			

小结:

毛细管血浆粘度: 1.78 CP ↑; 红细胞电泳指数: 20.70 ↑; 全血粘度低切: 10.91 CP ↑; 全血粘度中切: 8.17 CP ↑; 全血粘度高切: 6.37 CP ↑; 血浆粘度: 1.78 CP ↑。

检验科-生化	检验者:李烨	审核者: 赵敏忆	日期: 2025-09-05	
项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位
谷丙转氨酶（ALT）	11		0-75	U/L
谷草/谷丙转氨酶比值	2.45			
r-谷氨酰转肽酶（GGT）	32.0		16-73	U/L
碱性磷酸酶（ALP）	135	↑	45-125	U/L
总胆红素（T-BIL）	16.2		3.42-20.52	umol/L
直接胆红素（DB）	3.7		0-6.8	umol/L
胆汁酸（TBA）	5.50		0-10	umol/L
总蛋白（TP）	71.0		65-85	g/L
前白蛋白	202.0		160-450	mg/L
白蛋白（A1b）	47.9		40-55	g/L
球蛋白（GLB）	23.1		20-30	g/L
白/球比（A/G）	2.07		1.2-2.4	
白蛋白（ALBUMIN）	67.6	↑	52-65	%

检验科-生化		检验者:李烨	审核者: 赵敏忆	日期: 2025-09-05	
项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位	
α 1球蛋白 (ALPHA 1)	3.3		1.5-4	%	
α 2球蛋白 (ALPHA 2)	8.2		7-14	%	
β 球蛋白 (BETA)	10.2		6-13	%	
γ 球蛋白 (GAMMA)	10.7		10-19	%	
eGFR (MDRD)	102.28		>=90	mL/min per	
尿素氮 (BUN)	5.16		2.86-7.14	mmol/L	
肌酐 (CREA)	71		35-97	umol/L	
BUN/CREA (B/C)	0.07		0.04-0.08		
尿酸 (URIC)	290		208-428	umol/L	
视黄醇结合蛋白 (RBP)	32.4		25-70	mg/L	
胱抑素-C (Cys-C)	0.79		0.55-1.05	mg/L	
葡萄糖 (GLU)	5.00		3.9-6.1	mmol/L	
总胆固醇 (TC)	4.81		<5.2	mmol/L	
低密度脂蛋白 (LDL-C)	3.06	*	多参考值, 请结合临床	mmol/L	
高密度脂蛋白 (HDL-C)	1.51		>1.04	mmol/L	
甘油三酯 (TG)	1.01		<1.7	mmol/L	
脂蛋白 α (LP-α)	11.90		0-30	mg/dL	
载脂蛋白A1 (ApoA1)	1.82	↑	1.1-1.7	g/L	
载脂蛋白B (ApoB)	0.81		0.8-1.55	g/L	
ApoA1/ApoB	2.2	↑	0.7-2.1		
载脂蛋白C2 (ApoC2)	2.26		1.6-4.2	mg/dL	
小密低密度脂蛋白 (sdLDL)	1.23		0.23-1.37	mmol/L	
载脂蛋白E	4.9	↑	2.7-4.5	mg/dL	
钙	2.17		2-2.74	mmol/L	
镁	0.88		0.66-1.19	mmol/L	
铁	33.23		10.7-34	umol/L	
锌	28.39	↑	9.2-22.9	umol/L	
铜	13.36		11-24.4	umol/L	
钾	4.46		3.5-5.2	mmol/L	
钠	144.6		135-146	mmol/L	
氯	106.0		96-108	mmol/L	
磷	0.82		0.81-1.45	mmol/L	
同型半胱氨酸	13.4		0-15	umol/L	

检验科-生化		检验者:李烨	审核者:赵敏忆	日期: 2025-09-05	
项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位	
超敏C-反应蛋白 (HS-CRP)	1.70		0-3	mg/L	
肌酸激酶 (CK)	105		39-308	U/L	
磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB)	3.00		<12	U/L	
谷草转氨酶 (AST)	27		8-38	U/L	
α-羟丁酸脱氢酶 (HBDH)	148		72-182	U/L	
乳酸脱氢酶 (LDH)	196		106-211	U/L	
乳酸脱氢酶 (LDH1)	22.1		16.1-31.5	%	
乳酸脱氢酶 (LDH2)	30.5		29.2-41.6	%	
乳酸脱氢酶 (LDH3)	20.5		17-26.2	%	
乳酸脱氢酶 (LDH4)	9.1		5.9-12.3	%	
乳酸脱氢酶 (LDH5)	17.8	↑	3.2-17.3	%	
PRO-BNP	44.78		<285	pg/mL	

小结:

乳酸脱氢酶 (LDH5): 17.8 % ↑; 碱性磷酸酶 (ALP): 135 U/L ↑; 白蛋白 (ALBUMIN): 67.6 % ↑; 锌: 28.39 umol/L ↑; 低密度脂蛋白 (LDL-C): 3.06 mmol/L *; 载脂蛋白 A1 (ApoA1): 1.82 g/L ↑; ApoA1/ApoB: 2.2 ↑; 载脂蛋白E: 4.9 mg/dL ↑。

检验科-免疫		检验者:陈轶康	审核者:顾佳倍	日期: 2025-09-05	
项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位	
糖化血红蛋白 (HbA1c)	5.3		4-6	%	
可溶性ST2	25.32		<38	ng/mL	
三碘甲状腺原氨酸 (T3)	1.34		0.92-2.79	nmol/L	
甲状腺素 (T4)	95.40		58.1-140.6	nmol/L	
促甲状腺素 (TSH)	1.673		0.55-4.78	uIU/mL	
游离甲状腺素 (FT4)	16.32		11.5-22.7	pmol/L	
游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)	5.59		3.5-6.5	pmol/L	
TgAb	1.40		0-4.5	IU/mL	
TPO-Ab	123.90	↑	0-60	U/mL	
rT3	0.58		0.31-0.95	ng/mL	
TRAb	<0.80		<1.75	IU/L	
甲状腺球蛋白 (TG)	2.13		1.59-50.03	ng/mL	
β-CTX	0.70		≤0.854	ng/mL	
PTH	6.260		1.59-6.89	pmol/L	
总25-羟维生素D	38.68	↓	>50	nmol/L	
总P1NP	141.30	↑	9.06-76.24	ng/mL	

检验科-免疫				
检验者:陈轶康		审核者: 顾佳倍		日期: 2025-09-05
项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位
骨钙素	18.38		14-70	ng/mL
甲胎蛋白(AFP)	5.19		0-7	ng/mL
癌胚抗原(CEA)	2.65		0-5.2	ng/mL
糖类抗原(CA19-9)	29.30		0-39	U/mL
糖类抗原(CA125)	10.00		0-35	U/mL
糖类抗原(CA15-3)	14.10		0-25	U/mL
糖类抗原(CA211)	1.91		0-3.3	ng/mL
鳞癌相关抗原(SCC)	0.70		0-1.5	ng/mL
神经烯醇化酶(NSE)	12.10		0-16.3	ng/mL
糖类抗原(CA242)	3.44		0-20	U/mL
糖类抗原(CA724)	7.86	↑	0-6.9	U/mL
前列腺抗原(T-PSA)	0.43		0-4	ng/mL
游离前列腺抗原(F-PSA)	0.22		请结合临床	ng/mL
F-PSA/T-PSA	0.51		other	
PIVKA-II	30.88		0-40	mAU/mL
EBV-IgM	<10.00		<40	U/mL
EB病毒抗体测定EBNA-G	>600.00	↑	<20	U/mL
EB病毒抗体测定EBV-EA	<5.00		<40	U/mL
EB病毒抗体测定EBV-CA	90.20	↑	<20	U/mL
CMV-IgG	110.00	↑	<14	U/mL
CMV-IgM	<5.00		<22	U/mL
风疹病毒IgG	42.70	↑	<10	IU/mL
风疹病毒IgM	13.30		<25	AU/mL
TOX-IgG	<3.00		<8.8	IU/mL
TOX-IgM	<3.00		<8	AU/mL
抗'O' (ASO)	49.30		0-116	IU/mL
类风湿因子(RF)	<20.00		0-20	IU/mL
IgE-腰果/开心果/榛子/杏仁/核桃	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-小麦/荞麦	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-牛肉/羊肉	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-桃/芒果/苹果/荔枝/草莓	0.25		<0.35	IU/mL
IgE-鱼	0.00		<0.35	IU/mL

项目名称	检查结果	提示	参考范围	单位
IgE-虾/蟹	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-刺柏/桦	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-悬铃木/白蜡	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-桤/杨/柳/山毛榉/橡/胡桃	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-六月禾/黑麦草/梯牧草	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-藜/反枝苋	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-烟曲霉	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-念珠菌/点青霉/分枝孢霉/交链孢霉/黑曲霉	0.15		<0.35	IU/mL
IgE-鸡蛋黄	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-鸡蛋白	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-牛奶	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-花生/黄豆	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-芝麻	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-户尘螨	19.30		<0.35	IU/ml
IgE-粉尘螨	51.10		<0.35	IU/ml
IgE-热带无爪螨	7.90		<0.35	IU/ml
IgE-猫毛皮屑	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-狗毛皮屑	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-蟑螂	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-蚕丝	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-矮豚草	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-蒿	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-葎草	0.00		<0.35	IU/mL
IgE-复叶槭/桑/洋/槐/榆/柏/构树	0.00		<0.35	IU/mL
AFP-L3	<0.60		请结合临床	ng/mL
AFP-L3%	<5.00		0-10	%
糖类抗原(CA50)	16.50		0-25	U/mL

小结:

总25-羟维生素D: 38.68 nmol/L ↓; 总P1NP: 141.30 ng/mL ↑; IgE-户尘螨:19.30 IU/ml ;IgE-粉尘螨:51.10 IU/ml ;IgE-热带无爪螨:7.90 IU/ml ;糖类抗原(CA724): 7.86 U/mL ↑; F-PSA/T-PSA: 0.51; TPO-Ab: 123.90 U/mL ↑; CMV-IgG:110.00 U/mL ↑;风疹病毒IgG:42.70 IU/mL ↑;EB病毒抗体测定EBNA-G:>600.00 U/mL ↑;EB病毒抗体测定EBV-CA:90.20 U/mL ↑;

心电图室		小结医生:刘倍伶	日期: 2025-09-05
项目名称		检查结果	
心电图		正常心电图	
小结:			
正常心电图			

超声诊断科-心脏	书写医生:吴力军	日期: 2025-09-05
项目名称	检查结果	
检查所见	一、M型超声心动图 (mm)	
	单位:mm	正常值
主动脉根部内径	34.8 AA0 33.8	20—37
左室舒张末期内径	47	35—56 (男)
35—50 (女)		
左室收缩末期内径	29	
左房内径	36.7	19—40 (男)
19—35 (女)		
室间隔厚度	9 基底部/	6—11
左室后壁厚度	9	6—11
二、心功能:		
EF	68.4%	67%±8%
FS	38.3%	34%±5%
EDV	102ml	100.40ml±
33.64ml		
ESV	32.2ml	37.05ml±
11.88ml		
SV	69.8ml	86.4ml±13.6ml
CO	4.33L/min	3.5—8.0L/min
HR	62次/分	60—100次/分
三、描述(透声条件及图像质量)丙级:		
1. 各房室大小正常范围。		
2. 室间隔与左室后壁厚度正常,左室收缩活动未见明显异常。		
3. 主动脉、肺动脉无增宽。瓣膜开启良好。脉冲多普勒显示:瓣膜流速正常范围。彩色多普勒显示:无主动脉瓣反流。轻微肺动脉瓣反流。		
4. 二、三尖瓣回声正常,瓣膜开启活动良好。脉冲多普勒显示:瓣膜流速正常范围。二尖瓣口血流图显示:A峰<E峰。彩色多普勒显示:轻微二尖瓣反流。轻微三尖瓣反流。		
5. 房、室间隔未见明显缺损。		
四、组织多普勒显像(TDI):E'>A'。		

小结:

1. 静息状态下,心内结构大致正常

2. 左室收缩功能正常

项目名称	检查结果
检查所见	电子胃十二指肠镜检查常规:食管通畅, 齿状线粘膜破损<0.5cm, 蠕动扩张度好。 贲门粘膜光滑完整, 开闭自然。 胃底粘膜光滑, 完整。 胃体粘膜皱襞呈脑回状, 光滑。 胃角呈桥拱状, 粘膜光滑完整。 胃窦粘膜充血水肿, 散在隆起糜烂, 蠕动规则。 幽门呈圆形, 开闭良好。 十二指肠球部粘膜光滑完整。球后及降段未见异常。 操作时间约5分钟。患者一般情况可。记录检查过程顺利、患者无严重不良反应。 电子结肠镜检查麻醉:镜身到达回盲瓣。回盲区所见粘膜无殊, 回盲瓣开口正常, 唇状。 升结肠所见粘膜无殊。 横结肠所见粘膜粘无殊。 降结肠所见粘膜无殊。 乙状结肠所见粘膜无殊。 直肠粘膜无殊。见内痔。

小结:

反流性食管炎(LA-A), 隆起糜烂性胃窦炎, 建议定期复查。注意事项: 1、约2小时后可进食, 特殊情况医师会特意告知; 2、如有黑便等不适, 急诊就诊。详情在门诊大厅健康宣教中有明确告知。
内镜专科门诊时间: 每周一至周五下午, 周六上午。消化科门诊时间: 周一至周六全天。
所检结、直肠粘膜未见异常, 内痔。建议内镜专科门诊或消化科门诊随访, 定期复查。

内镜专科门诊时间: 每周一至周五下午。消化科门诊时间: 周一至周六全天。

项目名称	检查结果
胃镜病理	“胃窦”轻度慢性非萎缩性胃炎, HP (-)。

小结:

胃镜病理: “胃窦”轻度慢性非萎缩性胃炎, HP (-)。。

项目名称	检查结果
胆彩超	胆囊内可见团状增强伴声影, 随体位改变而移动, 大者直径约 7 mm。
肝彩超	肝脏切面形态、大小未见异常, 包膜光整, 实质回声均匀, 血管管腔显示清晰。
脾彩超	脾脏切面形态、大小未见异常, 实质回声均匀。
胰彩超	胰腺切面形态、大小未见异常, 实质回声均匀, 主胰管不扩张。

小结:

- 1) 胆囊结石
- 2) 左肾囊肿

项目名称	检查结果
甲状腺彩超	双侧甲状腺大小、形态正常, 包膜完整, 内部回声均匀, 未见明显异常回声区。双侧甲状腺血流信号一般。
颈部淋巴结彩超	双侧颈部未见明显异常低回声区。
甲状旁腺彩超	双侧甲状旁腺区域未见明显肿块。

超声诊断科-甲状腺	书写医生:陈寅	日期: 2025-09-05
-----------	---------	----------------

项目名称	检查结果
------	------

小结:

未见明显异常

超声诊断科-颈动脉	书写医生:陈寅	日期: 2025-09-05
-----------	---------	----------------

项目名称	检查结果
------	------

颈动脉彩超
双侧颈动脉内膜光滑,管腔通畅,未见明显斑块。
右侧颈总动脉内径约 6.1 mm,内中膜厚 0.6 mm,颈内动脉内径约 4.8 mm,颈外动脉内径约 4.5 mm.右侧颈总动脉血流速度: Vmax 78 cm/s, Vmin 26 cm/s, RI 0.67.
左侧颈总动脉内径约 6.5 mm,内中膜厚 0.5 mm,颈内动脉内径约 4.5 mm,颈外动脉内径约 4.2 mm.左侧颈总动脉血流速度: Vmax 84 cm/s, Vmin 26 cm/s, RI 0.69.

小结:

双侧颈动脉未见明显异常

超声诊断科-泌尿系统	书写医生:陈寅	日期: 2025-09-05
------------	---------	----------------

项目名称	检查结果
------	------

双肾彩超
左肾可见无回声区,大小约 11×8 mm。
输尿管彩超
双侧输尿管未见扩张
膀胱彩超
膀胱充盈,壁光滑,膀胱壁与膀胱内未见异常回声。
前列腺彩超
前列腺回声欠均匀,内见点状强回声。

小结:

前列腺钙化灶

医学影像科-X线摄片	小结医生:安维姝	日期: 2025-09-05
------------	----------	----------------

项目名称	检查结果
------	------

检查所见
所见胸廓及周围软组织未见明显异常。
纵隔未见明显增宽。
两侧横膈及肋膈角形态及位置正常。
心影形态大小位置正常。
两侧肺门形态及位置大小正常。
两肺野未见明显异常密度影。
颈椎生理曲度欠佳。
部分椎体前后缘骨质增生。
各椎间隙未见异常。

小结:

两肺未见明显活动性病变。
颈椎退行性改变。

肺功能室	小结医生:顾剑萍/徐伟萍	日期: 2025-09-05
------	--------------	----------------

项目名称	检查结果
------	------

FVC	90	%
FEV1%	78	%
FEV1.0	84	%

小结:

正常肺功能

项目名称	检查结果
检查所见	颅内脑灰白质界面清楚, 脑内未见明显异常信号, DWI未见明显高信号。颅内中线结构居中, 脑室系统形态及信号未见明显异常, 脑沟脑池未见明显异常。所见双侧上颌窦内见囊样T2WI高信号, 双侧筛窦黏膜增厚。头皮及颅骨未见明显异常。

小结:

头颅MRI未见明显异常。
双侧上颌窦黏膜下囊肿, 筛窦炎。

项目名称	检查结果
骨密度测定	骨量减少

小结:

骨密度测定: 骨量减少;

项目名称	检查结果
血管硬化检测	血管硬度: 在正常范围; 下肢血管检查在正常范围

小结:

未见明显异常

项目名称	检查结果
人体成分分析	肥胖型

小结:

人体成分分析: 肥胖型;

报告说明: 本次体检您所选择的检查项目并未涵盖所有脏器, 医生所作出健康指导是依据您的陈述和本次检查项目的结果而得出, 仅对本次体检的所查项目负责。此报告仅作健康保健之用, 不作任何证明依据。

咨询电话: 021-25076962 (接听时间: 周一至周五13:00-16:00, 节假日除外)

报告解读: 每周一至周五13:00-16:00 (节假日除外)

体检地址: 上海市新华医院 (控江路1665号) 医疗保健综合楼2楼健康管理中心

公交线路: 公交6路、70路、220路、14路、103路、841路、843路、716路、863路、871路及地铁8号线、18号线可直达



扫码查看影像



扫码查看报告

选择就医攻略->体检健康->个人报告

病区: 床号:

上海交通大学附属新华医院心电图报告单

日期: 2025-09-05 09:35:20

姓名: 王艺锋
性别: 男
年龄: 49岁

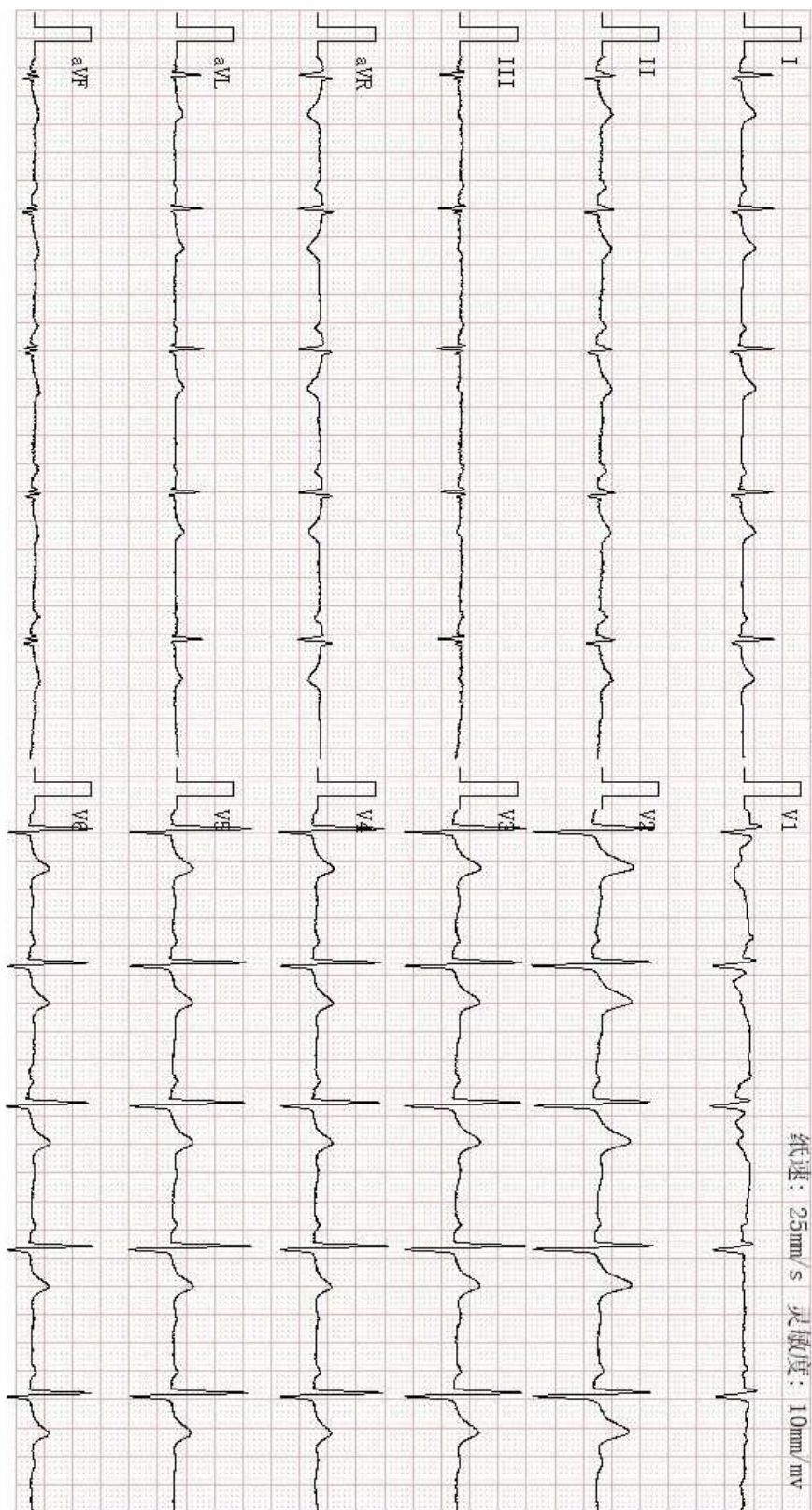
门诊号: 95279069
住院号:

心 房 率: 60
心 室 率: 60
临床诊断:

(参考值: 60~100)
(参考值: 60~100)

P-R: 168 (参考值: 120~200)
QT/QTc: 408/408 (参考值: 320~440/0~440)

纸速: 25mm/s 灵敏度: 10mm/mV



诊断提示:
正常心电图

报告医生: 刘磊 审核医生: 陈之民

本报告仅供临床医生参考

检测报告

受检者信息

受检者ID.....95279069

姓名.....王艺锋

出生日期.....1976-08-29 (49.0)

身高.....165.0 cm

种族/民族.....中国人

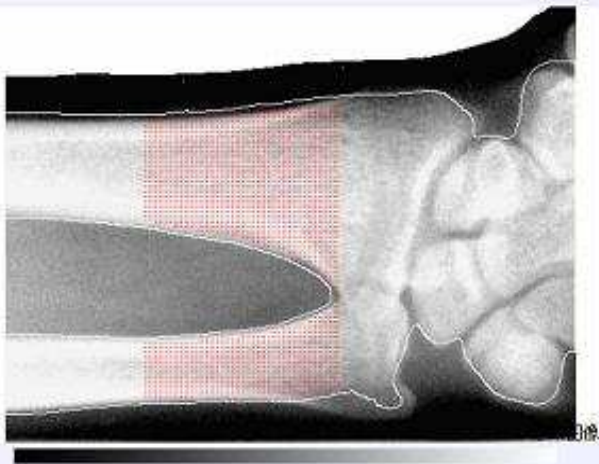
登记日期.....2025-09-05

性别.....男性

体重.....82.0 Kg

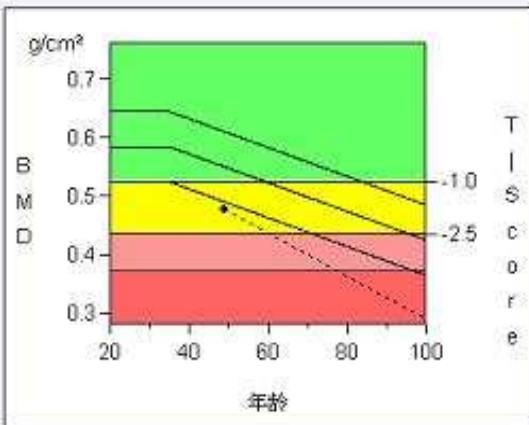
影像

左前臂



图表

T-Score : -1.8



结果

测量日期.....2025-09-05 09:23

BMD.....0.476 g/cm²

T-Score.....-1.8

Z-Score.....-1.2

BMC.....1.024 g (2.15 cm²)

成人比 (T-Ratio).....81.44 %

同龄比 (Z-Ratio).....86.55 %

注释

-2.5 < T值 < -1.0 骨量减少

世界卫生组织T值标准：
T-Score > -1 正常
-1 > T-Score > -2.5 骨量减少
-2.5 > T-Score 骨质疏松

医生姓名：zhenghui

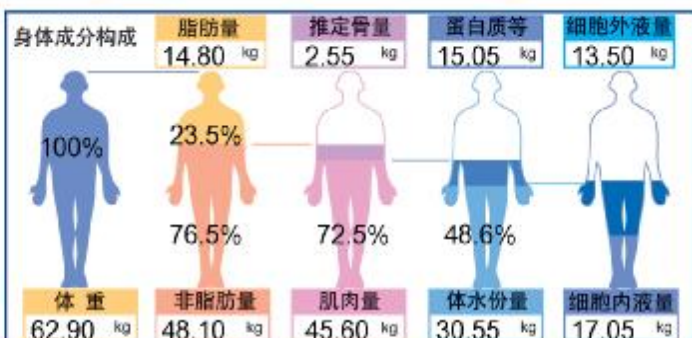
EXA-3000

OsteoSys
www.osteosys.com



姓名 王艺锋	年龄 49 岁	时间 2025年9月5日10:38	ID 95279069	性别 ☒ 男 ☐ 女
着衣重量 1.00 kg	身高 165.0 cm	体型 ☒ 普通人 ☐ 运动员	腰围 cm	臀围 cm
腰臀比 cm				

全身	测定结果	参考值
体重 Weight	62.90 kg	50.37~67.79kg
体脂肪率 Fat%	23.5 %	12.0~22.9%
脂肪量 Fat Mass	14.80 kg	6.56~14.29kg
非脂肪量 Fat Free Mass	48.10 kg	43.81~53.50kg
肌肉量 Muscle Mass	45.60 kg	48.20±4.20kg
推定骨量 Bone Mass	2.55 kg	2.90kg



身体水分量 TBW	30.55 kg	细胞外液量ECW	13.50 kg	细胞内液量ICW	17.05 kg
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

体脂肪率在正常范围的情况下，体水分率参考范围如下：

身体水分率 TBW	48.6 %	男性	女性
		55%~65%	45%~60%



通常依据体成分比率，可以得知肥胖者的细胞外液比率偏高。涉及医学诊断，请咨询专业医生。

细胞外液率 平均值	普通男性	40.6%	运动员男性	35.6%
	普通女性	41.8%	运动员女性	37.2%

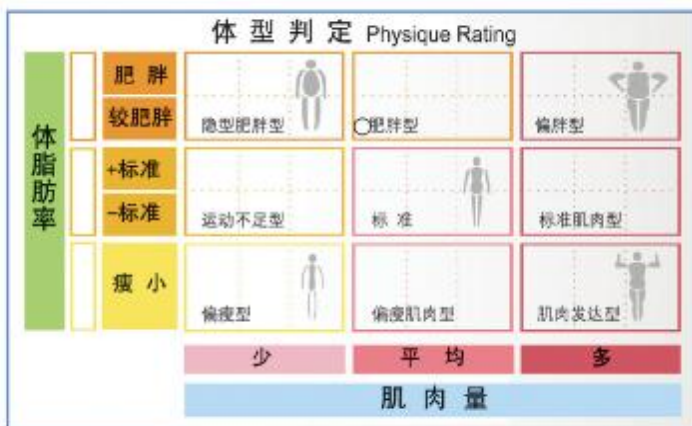
基础代谢量	1313 Kcal	能量消耗偏低	标准值	能量消耗偏高
参照值:	1376 Kcal			

基础代谢量 (BMR): 表示身体维持呼吸、心脏跳动和保持体温等基本生命活动而消耗的能量。占一天中的70%。基础代谢率低容易积累脂肪成为肥胖的原因。



内脏脂肪等级 Visceral Fat Rating	11	标准1~9	稍微超标10~14	过多15以上
-------------------------------	----	-------	-----------	--------

从医学上讲，进行腹部CT切片得出的内脏脂肪实测值超过100cm²时，容易引起糖尿病、高血压、高血脂等各种不良生活习惯造成的疾病。等级10即相当于100cm²的内脏脂肪。



肌肉综合评价	肌肉量
躯干部	24.75 kg
右上肢	2.15 kg
左上肢	2.00 kg
右下肢 (含臀)	8.45 kg
左下肢 (含臀)	8.25 kg

脂肪综合评价	脂肪量	体脂肪率
躯干部	9.30 kg	26.3 %
右上肢	0.50 kg	17.4 %
左上肢	0.50 kg	18.3 %
右下肢 (含臀)	2.30 kg	20.3 %
左下肢 (含臀)	2.25 kg	20.4 %

肌肉量平衡分析

生物电阻抗

	5kHz	50kHz	250kHz	500kHz
H-L	743.7 -30.1	657.7 -68.9	589.6 -62.6	578.3 -65.6
RL	287.6 -12.9	250.9 -26.9	226.2 -20.7	219.9 -21.6
LL	285.3 -11.4	251.8 -24.8	229.6 -19.0	224.4 -20.6
RH	414.0 -17.3	364.9 -42.0	318.6 -42.2	308.2 -45.3
LH	426.7 -16.9	378.5 -40.8	333.5 -41.3	324.6 -43.7
L-L	574.6 -25.2	498.7 -54.4	445.8 -43.3	432.3 -42.5

测试意见：肥胖型

请积极地进行运动和限制饮食以减低脂肪量，饮食要均衡，营养全面足够；参加均衡适当的运动。涉及医学诊断，请咨询专业医生。

目标体重：59.90 kg
体重控制：-3.00 kg
肌肉控制：+1.38 kg
脂肪控制：-4.38 kg